

회장도관(브리커)은 방광을 제거하거나 더 이상 정상적으로 기능하지 않을 때 소변을 배출하는 방법입니다. 집도의가 본인의 소장(회장) 일부를 이용해 신장에서 나오는 소변을 복부의 작은 개구부(장루)로 유도하며, 소변은 가볍고 편안한 소변 주머니에 모입니다. 가장 단순하고 가장 많이 시행되는 요로전환술입니다.

이 수술에 대하여

15~20cm 길이의 소장(회장) 조각을 **통로**로 사용합니다 — 소변을 저장하지 않고 흘려보내기만 합니다. 신장에서 오는 요관(소변을 운반하는 관)을 이 회장 조각에 연결하고, 한쪽 끝을 복부 피부로 꺼내어 **장루(스토마)**를 만듭니다. 주로 오른쪽 하복부에 위치합니다. 소변이 **지속적으로** 배출되므로 장루 위에 **소변 주머니(요루 주머니)**를 착용하여 하루에 여러 번 비워주고, 며칠마다 교체합니다.

- 소변을 참거나 도뇨관을 삽입할 필요가 없습니다.
- 나머지 장은 **다시 연결**되어 소화 기능은 정상적으로 유지됩니다.
- 장루 전문 간호사가 장루와 주머니 관리 방법을 교육합니다.

안전한가요?

회장도관(브리커)은 70년 이상 표준 요로전환술로 사용되어 온 가장 단순한 방법으로, 수술 시간도 짧습니다. 다른 대수술과 마찬가지로 출혈, 감염, 장이나 요관 문합부 누출 등의 위험이 있습니다. 장기적으로는 장루·피부 문제, 요로감염(UTI), 전해질·비타민 변화가 생길 수 있으며, 정기 추적 관찰을 통해 관리합니다.

용어 설명

요로전환술

방광이 없거나 기능하지 않을 때 소변이 몸 밖으로 나오는 새로운 경로를 만드는 수술.

회장도관(브리커)

소변을 장루까지 운반하는 짧은 소장 조각.

장루(스토마)

소변이 나오는 복부의 작은 개구부로, 소장으로 만듭니다.

소변 주머니(요루 주머니)

장루 위에 부착하여 소변을 모으는 주머니.

요관

신장에서 소변을 운반하는 관으로, 회장 조각에 연결합니다.

장루 전문 간호사

장루 위치를 표시하고 장루·주머니 관리를 교육하는 전문 간호사.

점액

장에서 분비되는 미끄러운 물질로, 소변에 섞여 나오는 것은 정상입니다.

주위 피부(장루 주변)

장루 주변 피부로, 청결하고 건강하게 유지해야 합니다.

아픈가요? 수술은 전신마취 하에 진행되므로 수술 중에는 아무것도 느끼지 못합니다. 수술 후에는 복부 불편감이 있으며, 장이 다시 움직이기까지 며칠이 걸립니다(처음에는 유동식부터 시작합니다). 장루 자체는 감각이 없습니다. 대부분 5-7일간 입원합니다.

준비 방법 (수술 전)

- **전신마취**로 진행됩니다 — 금식 및 복용 약물(혈액희석제 포함) 중단 등 수술 전 지시 사항을 모두 따르십시오. **장 세척(bowel prep)**이 필요할 수 있습니다.
- **장루 전문 간호사**와 만나 앉기·서기·눕기 자세에서 가장 적합한 장루 위치를 미리 표시합니다 — 편안하고 새지 않는 주머니 착용을 위해 중요합니다.
- **금연**하십시오 — 흡연은 회복을 늦춥니다 — 그리고 퇴원 후 도움을 받을 사람을 미리 준비하십시오.

다음에 해당하면 **미리 의료진에게 알려주세요**:

- **혈액희석제**를 복용 중이거나 현재 감염이 있는 경우
- 크론병·대장염 등 **장 질환**이 있거나, 복부 수술 또는 방사선 치료를 받은 적이 있는 경우

수술 진행 과정

- 1 전신마취 후 항생제를 투여합니다.
- 2 짧은 소장 조각을 분리하고 나머지 장을 다시 연결합니다.
- 3 요관을 소장 조각에 연결합니다.
- 4 한쪽 끝을 복부 밖으로 꺼내어 장루를 만들고, 회복을 돕기 위해 임시 스텐트와 배액관을 유치합니다.

수술 후

- 약 **5-7일** 후 퇴원합니다. 장루 전문 간호사가 **주머니 비우기**(하루 여러 번)와 **주머니 교체**(며칠마다) 방법을 교육합니다.
- 소변에 **점액**이 섞여 나오는 것은 정상입니다 — 장에서 분비됩니다.
- **수분을 충분히 섭취**하고, 장루 주변 피부를 청결하게 관리하십시오.
- 약 **6주간 무거운 물건을 들지 마십시오**. 신장 기능과 비타민 B12 수치를 확인하기 위해 평생 정기 검진이 필요합니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 장루가 어두운 색, 청색 또는 안쪽으로 함몰된 경우
- 수 시간 동안 주머니에 **소변이 거의 없거나 전혀 없는** 경우
- 심한 복통, 구토, 또는 **가스·대변이 나오지 않는** 경우(장 마비)
- 심한 출혈, 또는 상처 부위의 발적·분비물

기억할 세 가지

1. 회장도관(브리커)은 짧은 소장 조각을 이용해 소변을 복부 장루로 유도하고 주머니에 모으는 방법으로, 도뇨관이 필요 없는 가장 단순한 요로전환술입니다.
2. 수술 전 금식·장 세척 지시를 따르고, 장루 전문 간호사와 만나 장루 위치를 표시하며, 금연하고 도움받을 사람을 준비하십시오.
3. 소변 속 점액은 정상입니다. 장루 전문 간호사가 주머니·피부 관리를 교육합니다. 발열, 장루 색 변화, 소변 없음, 장 마비 증상이 있으면 즉시 연락하십시오.